

Cycle de préparation pour l'ECN

4-8-25

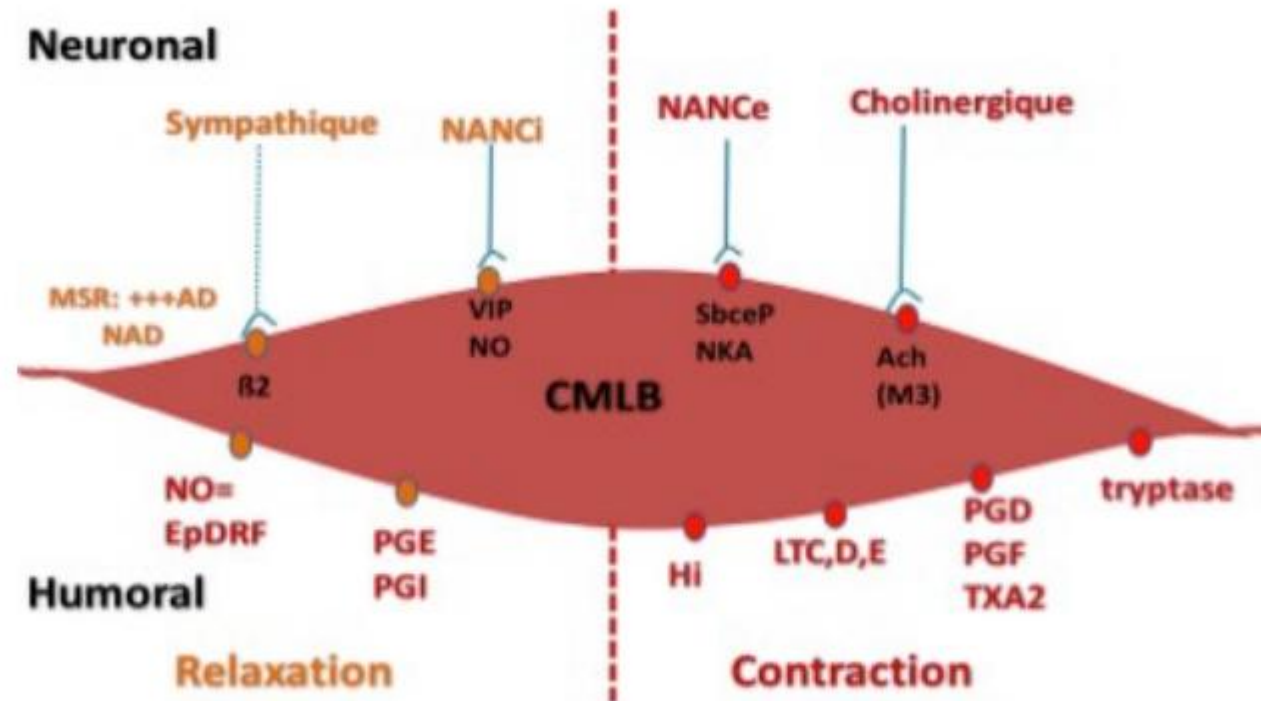
Dr Rahma GARGOURI

Service de pneumologie, CHU Hedi Chaker Sfax

abc

Concernant la physiopathologie de l'asthme:

- a. L'histamine est le principal agent bronchoconstricteur
- b. L'histamine exerce une action en stimulant les fibres C
- c. La thromboxane A₂ est bronchoconstrictrice
- d. Les prostaglandines ont un effet bronchodilatateur
- e. Le système NANC e est bronchodilatateur



Principaux messagers extracellulaires contrôlant l'activité mécanique du MLB par interaction avec un récepteur spécifique.

abd

Au cours de la crise d'asthme:

- A. La symptomatologie peut se limiter à une oppression thoracique par crises
- B. La dyspnée peut se résoudre spontanément
- C. Les symptômes sont typiquement de la même intensité
- D. La limitation du débit expiratoire est réversible
- E. Une fébricule est habituelle

ab

Quelles sont les propositions justes parmi les suivantes concernant l'asthme :

- A- L'asthme intrinsèque survient tardivement
- B- L'asthme touche les garçons plus fréquemment à l'enfance
- C- La prévalence de l'asthme est en nette diminution
- D- L'asthme est une maladie à déclaration obligatoire
- E- L'asthme touche plus fréquemment la race noire

ace

Les éléments qui causent l'obstruction bronchique dans la crise d'asthme incluent:

- a) Une inflammation de la muqueuse bronchique
- b) Un remodelage avec destruction des espaces aériens distaux
- c) Une hypersécrétion bronchique
- d) Un défaut de l'escalateur mucociliaire
- e) Une contraction du muscle lisse bronchique

abcd

L'asthme résulte de la conjonction de plusieurs facteurs comme:

- A- Une composante génétique
- B- Une obésité
- C- Un reflux gastro-oesophagien
- D- Tabagisme féminin lors de la grossesse (pour le bébé à naître)
- E- Une alimentation riche en fruits

abd

Il existe chez l'asthmatique:

- A. Une absence du système β_2 adrénergique.
- B. Une exagération des reflexes cholinergiques.
- C. Un déficit en surfactant
- D. Une hyper-réactivité bronchique
- E. Une destruction de l'armature de la paroi bronchique

e

Le traitement de première intention de la crise d'asthme modérée repose sur :

- A. Anticholinergique inhalé
- B. Ventilation non invasive
- C. Antihistaminique
- D. β -2 mimétiques de longue durée d'action
- E. β -2 mimétiques par voie inhalée

ACE

Lors du diagnostic étiologique de l'asthme, le (s) élément(s) faisant évoquer l'allergie est/sont:

- A. L'unité de temps et de l'espace de ses symptômes
- B. Le caractère sifflant de la dyspnée
- C. L'existence d'une rhinite
- D. La survenue nocturne de la crise
- E. La dermatite atopique

ACDE

La prise en charge d'une crise modérée d'asthme chez une femme enceinte de 37 SA comporte:

- a) Une hospitalisation obligatoire
- b) Une nébulisation d'anticholinergique
- c) Une nébulisation de beta2 mimétique
- d) Une corticothérapie orale
- e) Une échographie de vitalité foetale

bde

Pour évaluer le contrôle de l'asthme , les paramètres à considérer sont:

- a)Le débit expiratoire de pointe
- b)La fréquence des symptômes nocturnes
- c)La saturation en oxygène
- d)Le risque de survenue d'exacerbation
- e)Le retentissement sur le quotidien

BCE

Les facteurs de risque de mortalité par asthme incluent:

- A. L'antécédent de ventilation mécanique pour AVC
- B. L'allergie médicamenteuse
- C. Mauvaise observance thérapeutique
- D. L'obésité
- E. sur-utilisation de beta 2 de secours

acde

Les critères de gravité d'une crise d'asthme sont:

- a) Une tachypnée
- b) Un débit expiratoire de pointe à 70 % de la théorique
- c) Une normocapnie
- d) Un silence auscultatoire
- e) Une impossibilité de parole

d

La pièce angulaire du traitement de fond de l'asthme est:

- a) Un anticholinergique inhalé
- b) Un antileucotriène
- c) Un bêta 2 de longue durée d'action
- d) Un corticoïde inhalé
- e) Un antihistaminique

abce

Au cours d'une crise d'asthme sévère, le traitement doit:

- a) Être débuté à domicile, et continuer durant le transport du malade
- b) Doit se faire dans un service spécialisé
- c) Peut comporter l'administration de sulfate de magnésium par voie orale
- d) La corticothérapie est à administrer après amélioration des signes cliniques
- e) L'évaluation clinique doit être pluriquotidienne avec expectante armée

de

Devant un malade qui présente une toux chronique, les arguments en faveur de l'asthme sont:

- A. Bronchorrhée matinale
- B. Dyspnée constante
- C. Stridor
- D. Oppression thoracique
- E. recrudescence nocturne

Une jeune femme de 25 ans se présente à votre consultation pour des symptômes respiratoires récidivants survenant 1 à 2 fois par semaine à type d'essoufflement avec sifflements intrathoraciques s'améliorant spontanément en 5 à 10 minutes.

En l'absence d'argument clinique retrouvé pour un diagnostic différentiel, vous évoquez le diagnostic d'asthme. Elle fume et refuse d'arrêter de fumer.

be

Parmi les propositions de prise en charge ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. il faut instaurer un traitement inhalé dès la réalisation d'une spirométrie
- B. il faut proposer un sevrage tabagique
- C. il faut débiter par un bronchodilatateur de courte durée d'action en monothérapie à la demande
- D. il faut limiter la pratique d'une activité physique
- E. il faut rédiger un plan d'action sur la conduite à tenir en cas d'exacerbation

Un traitement de fond, à prendre TOUS LES JOURS, doit être instauré dès que le diagnostic d'asthme est évoqué.

Il repose sur la corticothérapie inhalée, en débutant par un palier 2 ou 3 en fonction du niveau de contrôle de l'asthme.

En pratique on considère que des symptômes survenant plus de 2 fois par mois nécessitent la mise en route du traitement de fond.

L'asthme ne doit pas être traité par bronchodilatateur seul.

C

Devant un patient asthmatique ayant une crise sévère, votre conduite à tenir en urgence à domicile est:

- A. Réanimation cardio-respiratoire
- B. Salbutamol par voie inhalée 2 bouffées et réévaluation à 30 minutes
- C. Salbutamol par voie inhalée avec une chambre d'inhalation et transfert médicalisé vers l'hôpital
- D. Corticothérapie orale et réévaluation dans 48 heures
- E. Mise en place d'aérosols à domicile pour une durée de 3 jours

acd

Devant une dyspnée paroxystique, l'asthme peut être **fortement suspecté** devant :

- A- L'atopie
- B- L'amélioration du débit expiratoire de pointe de plus de 20% d'une consultation à une autre
- C- Le sifflement thoracique
- D- L'augmentation du VEMS d'au moins 12 % et 200 ml après bronchodilatateurs
- E- Le syndrome bronchique sur la radiographie thoracique

Un DVO est dit **réversible** si le **VEMS augmente de plus de 200 ml et 12%** par rapport aux valeurs initiales.

La **réversibilité complète** d'un DVO quand :

- **normalisation du rapport VEMS/CVF ($> 0,7$)**

ET

- **normalisation du VEMS ($\text{VEMS} > 80 \% \text{ de la valeur prédite}$)**

A noter, que cette réversibilité totale peut disparaître dans l'asthme sévère.

La variabilité du DVO :

Cette variabilité peut être objectivée par la réalisation d'un monitoring du VEMS.

Ce test consiste à la réalisation d'une courbe débit / Volume à différents moments de la journée.

La variabilité intra ou inter journalière est définie par une variation du VEMS de plus de 20% entre deux mesures et le DEP (débit expiratoire de pointe) peut être surveillé de façon plus simple de 10% chez l'adulte et de 15% chez l'enfant). Cette variation est en faveur de l'asthme).

Le test aux corticoïdes inhalés pendant 1 mois montre une augmentation du VEMS > 20%

abc

Au cours de la maladie asthmatique **allergique**:

- A. Le taux des éosinophiles bronchiques est corrélé à la sévérité de la maladie asthmatique
- B. L'inflammation bronchique est de type TH2
- C. La Fe NO est utilisée pour juger l'efficacité du traitement
- D. Le remodelage bronchique est constant
- E. L'obstruction bronchique est fixe

abe

Les FDR d'une irréversibilité du TVO dans l'asthme:

- a. Tabac
- b. mauvaise observance des CSI
- c. Obésité
- d. Eviction professionnelle
- e. Hypersécrétion bronchique

abcd

Concernant le traitement de fond de l'asthme:

- a. L'omalizumab est préconisé pour les asthmes sévères
- b. L'omalizumab pose un problème de coût
- c. Mépolizumab est préconisé pour l'asthme éosinophilique
- d. Les antileucotriènes sont de derniers recours
- e. L'immunothérapie spécifique est indiquée dans les asthmes mal contrôlés

abcd

Lors d'une consultation de routine chez un asthmatique, le médecin doit:

- A. Vérifier l'observance thérapeutique
- B. Vérifier la technique d'inhalation
- C. Vérifier l'inocuité du traitement
- D. Discuter un changement de dispositif selon les préférences du malade
- E. pratiquer une EFR de manière trimestrielle

bcde

Les propositions correctes à propos de l'AAG sont:

- A. Ne survient pas en cas d'asthme intermittent
- B. C'est une crise inhabituelle ne répondant pas au traitement habituel
- C. Il peut menacer le pronostic vital
- D. La prise en charge se fait en milieu de réanimation
- E. La mesure du DEP peut s'avérer difficile

be

Devant un AAG, les traitements incluent:

- A. Nébulisation de Sulfate de magnésium
- B. Salbutamol à la seringue électrique
- C. Corticothérapie orale
- D. Antihistaminique injectable
- E. Nébulisation d'anticholinergique

abe

Ali consulte pour une dyspnée sifflante récurrente notamment la nuit, avec une toux et une sensation d'oppression thoracique à raison d'une fois par mois. Le jour de la consultation, il était asymptomatique. Par ailleurs, vous remarquez qu'il a un surpoids. Vous suspecter l'asthme.

Les mesures à prendre sont:

- A. Spirométrie avec test de réversibilité
- B. Association fixe de budesonide formoterol au besoin
- C. Prick test alimentaire
- D. Contre indication de la natation
- E. Prise en charge nutritionnelle

					PALIER 5 Dose forte de CSI + formotérol ± LAMA, après évaluation phénotypique: ± anti IgE, ou anti IL4R, ou anti IL5
			PALIER 4 Dose moyenne de CSI + formotérol		
		PALIER 3 Faible dose de CSI + formotérol			
	PALIER 1 et 2 à la demande, faible dose de CSI + formotérol				
Traitement de fond et des symptômes option 1 préférentielle: prévention des exacerbations et contrôle des symptômes par CSI+formotérol		À la demande, faible dose de CSI + formotérol			
					PALIER 5 Dose forte de CSI+LABA, ± LAMA, après évaluation phénotypique: ± anti IgE, ou anti IL4R, ou anti IL5
	PALIER 1 CSI à chaque fois qu'un SABA est administré	PALIER 2 CSI faible dose en continu	PALIER 3 Faible dose de CSI + LABA	PALIER 4 Dose moyenne de CSI + LABA	
option 2: traitement de fond et alternative pour les symptômes Avant d'envisager un traitement par SABA, vérifier auparavant l'adhérence à un traitement de fond quotidien					
	β2-agoniste de courte durée d'action (SABA) à la demande				
Autres options de traitement de fond (valables pour les 2 options)	la prise isolée de SABA n'est pas recommandée	Montelukast, ou faible dose de CSI à chaque prise de β2-agonistes de courte durée d'action (SABA)	Dose moyenne de CSI, ou dose faible de CSI + montelukast	Dose forte de CSI; traitement additionnel par tiotropium ou montelukast	-Azithromycine (adultes) -faible dose de corticoïde oral, en tenant compte des effets indésirables

Figure 2 : Paliers thérapeutiques du traitement de fond de l'asthme (GINA 2021) OBJ.18-